

QUANDO & O QUE

Quando avaliar

Queixa (paciente/informante), declínio vs. prévio, perda de AVD, confusão aguda, polifarmácia

Rastreio ≠ formal

Rastreio: breve, médico (MEEM/MoCA/relógio). Formal: neuropsicólogo, perfil por domínio

DIFERENCIAIS

Continuum

Normal → DCS → CCL → demência.
CCL × demência = impacto nas AVD

3 D

Delirium (agudo/flutuante) · Depressão (melhora c/ pistas) · Demência (insidiosa, não recupera)

Pseudodemência

Depressão imitando demência → tratar e reavaliar

RASTREIO

MEEM (0-30)

SEMPRE ajustar à escolaridade (Brucki 2003); pouco sensível a CCL

MoCA (<26)

+ sensível a CCL/executivo; +1 pt se ≤12 anos

Rápidos

Relógio · fluência (animais) · Mini-Cog

Informante

IQCODE: compara com o passado; pouco afetado por escolaridade

DOMÍNIOS & CONDUTA

6 domínios (DSM-5)

Atenção · executivo · memória · linguagem · perceptomotor · social

Diagnóstico

Síndrome → excluir 2ª (TSH, B12, Na) → neuroimagem → etiologia

Conduta

CCL: risco vascular, exercício, desprescrever. Demência: não-farmacológico, cuidador

RÉGUA DO DIAGNÓSTICO COGNITIVO

Antes de dizer DEMÊNCIA, exclua os 3 D (Delirium · Depressão · Demência) e os 3 que enganam o teste — E·S·A: Escolaridade · Sentidos (visão/audição) · Ânimo (humor). O score é um dado, não o diagnóstico.

CHAVES

- **Funcionalidade** separa CCL de demência.
- **Memória que melhora com pistas** → depressão/disexecutivo, não amnésia hipocampal.
- **Informante** é essencial; rastreio levanta hipótese, diagnóstico é clínico/sindrômico.